

Dokument	Fussdiagramm	Verabw.	Bemerkung
----------	--------------	---------	-----------

Schmerzmanagement bei chronischen und akuten Schmerzen nach Expertenstandard

I. Schmerzeinschätzung und Differenzierung

1. bis 6. PFK

1. Erfolgt unmittelbar zu Beginn des pflegenden Auftrags und wenn keine Schmerzen vorliegen in individuell festgelegten Zeitabständen

Die Schritte 1 bis 3 erfolgen analog dem „Akuten Schmerz“

2. (zu erwartende) Schmerzen, schmerzbedingte Probleme vorhanden? Schmerzen akut oder chronisch?

ja

3. Keine weiteren Maßnahmen

nein

4. Differenzierung: Schmerzen akut oder chronisch?

akut

5. Weiter mit Schmerzmanagement bei akuten Schmerzen

PFK

Informiert behandelnden Arzt. Wenn schon Bedarfsergänzung vorliegt schlopt sie die Anordnung aus, führt Verkaufskontrolle

6. Im Rahmen des Assessments sind auch Faktoren zu erfassen, die die Schmerzsituation stabilisieren oder destabilisieren können

7. Auch bei einem Bewohner mit Demenz und dadurch bedingt schwer einschätzender Schmerzsituation kann ein pflegender Schmerzexperte hinzugezogen werden

7./8. PFK

II. Individuelle Schmerztherapie und Maßnahmen – Planung

8. Einschätzung der Schmerzsituation mit einem differenzierten, kritiengeleitetes Assessment

9. Arzt, Schmerz-experte, PFK, Schmerz-Experte

9. Das multiprofessionelle Team (z. B. Arzt, Physiotherapeut, Apotheker, PFK etc.) arbeitet nach den Kriterien des hausinternen Standards zusammen

Zur Behandlung der chronischen Schmerzen wird ein individueller Behandlungsplan erstellt, der u. a. die ärztlich verordnete medikamentöse Therapie, die gegebenenfalls medikamentösen Maßnahmen und jeweils festgelegten Therapiezielen enthält.

Die Selbstmanagementkompetenz des Bewohners wird dabei berücksichtigt!

Screening 1. Initiales Schmerzassessment

1. Einschätzung von zu erwartenden Schmerzen, schmerzbedingten Problemen

2.

(zu erwartende) Schmerzen, schmerzbedingte Probleme vorhanden? Schmerzen akut oder chronisch?

ja

4. Differenzierung: Schmerzen akut oder chronisch?

akut

5. Weiter mit Schmerzmanagement bei akuten Schmerzen

PFK

Informiert behandelnden Arzt. Wenn schon Bedarfsergänzung vorliegt schlopt sie die Anordnung aus, führt Verkaufskontrolle

chronisch

Assessment 6. Differenziertes, kritiengeleitetes Schmerzassessment

6. Schmerzsituation instabil?

nein

7.

Information an den Arzt und Hinzuziehen eines pflegenden Schmerzexperten

8. Einschätzung der Schmerzsituation mit einem differenzierten, kritiengeleitetes Assessment

9.

Planung medikamentöser Maßnahmen nach ärztlicher Anordnung

Definition individueller Therapieziele

nicht-medikamentöser Maßnahmen

9. Arzt, Schmerz-experte, PFK, Schmerz-Experte

9. Das multiprofessionelle Team (z. B. Arzt, Physiotherapeut, Apotheker, PFK etc.) arbeitet nach den Kriterien des hausinternen Standards zusammen

Zur Behandlung der chronischen Schmerzen wird ein individueller Behandlungsplan erstellt, der u. a. die ärztlich verordnete medikamentöse Therapie, die gegebenenfalls medikamentösen Maßnahmen und jeweils festgelegten Therapiezielen enthält.

Die Selbstmanagementkompetenz des Bewohners wird dabei berücksichtigt!

III. Information, Beratung und Schulung des Bewohners und seiner Angehörigen

10. Information, Beratung und Schulung von Bewohner und Angehörigen	Besteht ein spezieller Beratungsbedarf?	nein	12. Keine Maßnahmen erforderlich	13. PFK, Schmerz- experte	IV. Individuelle Schmerztherapie und Maßnahmen – Koordination und Durchführung
	11. Besteht ein spezieller Beratungsbedarf?	nein	12. Keine Maßnahmen erforderlich	13. PFK, Schmerz- experte	
10. Information, Beratung und Schulung von Bewohner und Angehörigen	10. Der Bewohner und ggf. seine Angehörigen werden individuell über seine Schmerzsituation informiert, beraten und geschult. Er wird in den Kompetenzen seines Selbstmanagements unterstützt und gefördert. Es werden individuelle Ziele zu seiner Schmerzsituation vereinbart. Die Pflegefachkraft muss sich dabei mit allen an dem Schmerzmanagement beteiligten Berufsgruppen absprechen	10. bis 12. PFK	10. Der Bewohner und ggf. seine Angehörigen werden individuell über seine Schmerzsituation informiert, beraten und geschult. Er wird in den Kompetenzen seines Selbstmanagements unterstützt und gefördert. Es werden individuelle Ziele zu seiner Schmerzsituation vereinbart. Die Pflegefachkraft muss sich dabei mit allen an dem Schmerzmanagement beteiligten Berufsgruppen absprechen	13. PFK, Schmerz- experte	IV. Individuelle Schmerztherapie und Maßnahmen – Koordination und Durchführung
	10. Der Bewohner und ggf. seine Angehörigen werden individuell über seine Schmerzsituation informiert, beraten und geschult. Er wird in den Kompetenzen seines Selbstmanagements unterstützt und gefördert. Es werden individuelle Ziele zu seiner Schmerzsituation vereinbart. Die Pflegefachkraft muss sich dabei mit allen an dem Schmerzmanagement beteiligten Berufsgruppen absprechen	10. bis 12. PFK	10. Der Bewohner und ggf. seine Angehörigen werden individuell über seine Schmerzsituation informiert, beraten und geschult. Er wird in den Kompetenzen seines Selbstmanagements unterstützt und gefördert. Es werden individuelle Ziele zu seiner Schmerzsituation vereinbart. Die Pflegefachkraft muss sich dabei mit allen an dem Schmerzmanagement beteiligten Berufsgruppen absprechen	13. PFK, Schmerz- experte	
14. Koordination, Durchführung und Kontrolle der Maßnahmen	14. In Absprache mit den beteiligten Berufsgruppen werden die Maßnahmen nach dem individuellen Behandlungsplan koordiniert. Die Durchföhrung der medizinischen Maßnahmen wird sicher-gestellt. Die pflegenden nicht-medikamentösen Maßnahmen werden durchgeföhrt. Bei pflegenden Handlungen wird ein schmerzreduzierendes Vorgehen vermieden.	14. PFK	14. In Absprache mit den beteiligten Berufsgruppen werden die Maßnahmen nach dem individuellen Behandlungsplan koordiniert. Die Durchföhrung der medizinischen Maßnahmen wird sicher-gestellt. Die pflegenden nicht-medikamentösen Maßnahmen werden durchgeföhrt. Bei pflegenden Handlungen wird ein schmerzreduzierendes Vorgehen vermieden.	14. PFK	V. Evaluation
	14. In Absprache mit den beteiligten Berufsgruppen werden die Maßnahmen nach dem individuellen Behandlungsplan koordiniert. Die Durchföhrung der medizinischen Maßnahmen wird sicher-gestellt. Die pflegenden nicht-medikamentösen Maßnahmen werden durchgeföhrt. Bei pflegenden Handlungen wird ein schmerzreduzierendes Vorgehen vermieden.	14. PFK	14. In Absprache mit den beteiligten Berufsgruppen werden die Maßnahmen nach dem individuellen Behandlungsplan koordiniert. Die Durchföhrung der medizinischen Maßnahmen wird sicher-gestellt. Die pflegenden nicht-medikamentösen Maßnahmen werden durchgeföhrt. Bei pflegenden Handlungen wird ein schmerzreduzierendes Vorgehen vermieden.	14. PFK	
15. Anfallsbezogene und regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit der pflegenden Maßnahmen und der Therapieziele	15. Anfallsbezogene und regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit der pflegenden Maßnahmen und der Therapieziele	15. bis 20. PFK	15. Anfallsbezogene und regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit der pflegenden Maßnahmen und der Therapieziele	15. bis 20. PFK	V. Evaluation
	15. Anfallsbezogene und regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit der pflegenden Maßnahmen und der Therapieziele	15. bis 20. PFK	15. Anfallsbezogene und regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit der pflegenden Maßnahmen und der Therapieziele	15. bis 20. PFK	
16. Anpassungen erforderlich?	16. Anpassungen erforderlich?	nein	17. Geplante Maßnahmen weiter umsetzen	17. Geplante Maßnahmen weiter umsetzen	V. Evaluation
	16. Anpassungen erforderlich?	nein	17. Geplante Maßnahmen weiter umsetzen	17. Geplante Maßnahmen weiter umsetzen	
18. Erforderliche Anpassung umsetzen	18. Erforderliche Anpassung umsetzen	ja	18. Erforderliche Anpassung umsetzen	18. Erforderliche Anpassung umsetzen	V. Evaluation
	18. Erforderliche Anpassung umsetzen	ja	18. Erforderliche Anpassung umsetzen	18. Erforderliche Anpassung umsetzen	
19. Schmerz-situation instabil?	19. Schmerz-situation instabil?	nein	20. Geplante Maßnahmen weiter umsetzen	20. Geplante Maßnahmen weiter umsetzen	V. Evaluation
	19. Schmerz-situation instabil?	nein	20. Geplante Maßnahmen weiter umsetzen	20. Geplante Maßnahmen weiter umsetzen	
21. Information an den Arzt und Hinzuziehen eines pflegenden Schmerzexperten	21. Information an den Arzt und Hinzuziehen eines pflegenden Schmerzexperten	ja	21. Information an den Arzt und Hinzuziehen eines pflegenden Schmerzexperten	21. Information an den Arzt und Hinzuziehen eines pflegenden Schmerzexperten	V. Evaluation
	21. Information an den Arzt und Hinzuziehen eines pflegenden Schmerzexperten	ja	21. Information an den Arzt und Hinzuziehen eines pflegenden Schmerzexperten	21. Information an den Arzt und Hinzuziehen eines pflegenden Schmerzexperten	
22. Behandlungsplan anpassen	22. Behandlungsplan anpassen	ja	22. Behandlungsplan anpassen	22. Behandlungsplan anpassen	V. Evaluation
	22. Behandlungsplan anpassen	ja	22. Behandlungsplan anpassen	22. Behandlungsplan anpassen	